

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE ACTIVACIÓN CONDUCTUAL PARA LA DEPRESIÓN (BADs)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de Activación, Evitación, Rumiación y Deterioro Funcional

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Activación Conductual para la Depresión (BADs).
Nombre Original (Inglés)	<i>Behavioral Activation for Depression Scale (BADs)</i>
Autores Originales	Drs. Jonathan W. Kanter, Andrew M. Mulick, Andrew M. Busch et al. (2007).
Adaptación Española	Jorge Barraca, Marino Pérez-Álvarez y Roberto Lozano Bleda (2011), Univ. Camilo José Cela.
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Terapia de Activación Conductual (Martell / Jacobson).
Tipo de Instrumento	Autoinforme de monitorización procesual de 25 reactivos tipo Likert de 7 puntos (0 a 6).
Población y Rango	Adultos y jóvenes (desde los 16 años). Especialmente indicado en depresión mayor y distimia.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos en autoadministración; 10 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento científico abierto para uso clínico y de investigación sin royalties.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DE ACTIVACIÓN CONDUCTUAL

La BADs fue diseñada con el propósito específico de operacionalizar y monitorizar sesión a sesión los cambios conductuales que median la eficacia de la Terapia de Activación Conductual (AC) para la depresión. Enraizada en los modelos contextuales conductuales (Ferster, Lewinsohn, Martell y Jacobson), la escala postula que la depresión se instaura y se cronifica debido a un ciclo vicioso de escape pasivo, rumiación estéril y desconexión social ante estresores aversivos.

Neurobiológicamente, la falta de activación conductual se vincula a una hipofunción del circuito frontoestriatal de la recompensa (caudado, putamen y núcleo accumbens) asociada a hipoactividad en el córtex prefrontal dorsolateral izquierdo. Al evaluar conjuntamente tanto la conducta proactiva orientada a metas (**Activación**) como las conductas mantenedoras de la patología (**Evitación/Rumiación** y los deterioros funcional y social), la BADs proporciona una radiografía precisa de las contingencias ambientales del paciente.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Subescala BADs	Ítems	Rango	Definición Operacional y Contenido Clínico
1. Activación (AC)	3, 5, 7, 8, 11, 12, 13 (7)	0 a 42	Iniciativa conductual, ejecución de planes cotidianos, consecución de metas y persistencia en actividades con significado.
2. Evitación / Rumiación (ER)	1, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 24 (8)	0 a 48	Conductas de escape pasivo (quedarse en la cama, aislarse) y rumiación mental en lugar de actuar sobre los problemas.
3. Deterioro Laboral / Escolar	14, 16, 20, 22, 23 (5)	0 a 30	Abandono de deberes profesionales o formativos, pérdida de productividad y quejas por incompetencia percibida.
4. Deterioro Social (DS)	2, 4, 6, 10, 25 (5)	0 a 30	Cancelación de compromisos interpersonales, evitación de llamadas y repliegue respecto al círculo de amigos y familia.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión global: alfa de Cronbach de 0.90 para la escala total en adaptación española (Barraca et al., 2011); Activación (0.83), Evitación/Rumiación (0.85), Det. Laboral (0.78) y Det. Social (0.84).
Estructura Tetrafactorial	El AFC ratifica el modelo de cuatro factores correlacionados (CFI = 0.94, RMSEA = 0.052), replicando de forma fiel la solución estructural norteamericana original de Kanter.
Validez Concurrente	Elevada correlación inversa con gravedad depresiva (BDI-II, $r = -0.72$) y rumiación (RRS, $r = -0.62$); y correlación directa muy alta con refuerzo ambiental observado (EROS, $r = 0.74$).
Sensibilidad al Cambio Semanal	Diseñada expresamente como medida de proceso sensible al cambio sesión a sesión, anticipando las mejorías sintomáticas en depresión antes de que remita el afecto negativo.
Validez Predictiva	El factor Activación predice de manera independiente el retorno laboral y la no cronificación en pacientes con bajas por trastornos adaptativos y afectivos.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada reactivo evalúa la conducta en la **última semana** de 0 a 6 (**0** = «Para nada», **3** = «Moderadamente», **6** = «Completamente»):

- **1. Puntuación de Activación (AC):** Suma directa de los ítems **3 + 5 + 7 + 8 + 11 + 12 + 13** (Rango: **0 a 42 puntos**).
- **2. Puntuación de Evitación/Rumiación (ER):** Suma directa de los ítems **1 + 9 + 15 + 17 + 18 + 19 + 21 + 24** (Rango: **0 a 48**).
- **3. Deterioro Laboral/Escolar (DL):** Suma directa de los ítems **14 + 16 + 20 + 22 + 23** (Rango: **0 a 30 puntos**).
- **4. Deterioro Social (DS):** Suma directa de los ítems **2 + 4 + 6 + 10 + 25** (Rango: **0 a 30 puntos**).
- **Puntuación Global de Activación:** Se calcula invirtiendo las tres escalas disfuncionales: Total = AC + (48 – ER) + (30 – DL) + (30 – DS) (Rango total: **0 a 150 puntos**). A mayor puntuación, mayor activación adaptativa global.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (TOTAL BADS)

Nivel BADS	Puntuación	Perfil de Funcionamiento	Conducta Asistencial Recomendada
Inactivación Severa	0 a 70	Parálisis conductual extrema (corte <= 70)	Indicación prioritaria de Activación Conductual intensiva. Programación de actividades mínimas y apoyo externo.
Moderada	71 a 105	Activación parcial con evitación activa	El paciente cumple tareas básicas pero se repliega socialmente o rumea en casa. Desarticular bucles de escape.
Alta / Funcional	106 a 150	Funcionamiento adaptativo activo	Nivel óptimo de conductas propositivas y contacto con reforzadores. Mantener y consolidar hábitos saludables.

SIGNIFICACIÓN CLÍNICA DE LA SUBESCALA EVITACIÓN/RUMIACIÓN (ER >= 25):

Una puntuación en **Evitación/Rumiación >= 25 puntos** revela que la pasividad del paciente no se debe únicamente a falta de energía física, sino a una conducta activa de escape experiencial para no enfrentar la ansiedad o el fracaso. Trabajar directamente en romper la evitación pasiva antes de exigir logros laborales.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN ACTIVACIÓN CONDUCTUAL

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN SEMANAL GUIADO POR LA BADS:

- **Semana 1 (Línea Base BADS):** Identificar el factor más deteriorado. Si **Deterioro Social > 20**, enfocar las primeras intervenciones en reactivar un contacto interpersonal seguro; si **Evitación > 30**, priorizar salir de la cama a una hora fija.
- **Semanas 2 a 6 (Programación Jerarquizada):** Seleccionar conductas concretas observables alineadas con el factor Activación (ej. caminar 15 min, cocinar un plato saludable). Aplicar la regla: "Actuar de fuera hacia adentro" (la acción precede a la motivación).
- **Evaluación de Progreso Semanal:** Un aumento de **>= 15 puntos en el BADS Total** predice respuesta terapéutica robusta y remisión en las escalas sintomáticas como el PHQ-9.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DEPRESIÓN GRAVE Y APATÍA

Paciente: Varón de 50 años, arquitecto técnico en situación de incapacidad laboral temporal por depresión mayor, consulta tras 6 meses encerrado en su domicilio con anhedonia completa y descuido del autocuidado personal.

Resultados Iniciales en BADS: Total Global = **42 / 150 puntos** (Inactivación severa extrema).

• **Subescalas:** Activación = **6 / 42**; Evitación/Rumiación = **40 / 48** (permanece hasta 14 horas diarias tumbado rumiando); Deterioro Laboral = **26 / 30**; Deterioro Social = **26 / 30** (rechaza llamadas de amigos y familiares).

Formulación Clínica: Trampa de evitación depresiva masiva. La conducta de permanecer tumbado funciona como alivio inmediato de la ansiedad pero aniquila cualquier contacto con reforzadores positivos ambientales.

Tratamiento y Resultados: Plan de Activación Conductual (BATD) de 12 semanas: establecimiento de rutina de higiene y desayuno a las 8:30, paseo de 20 minutos matinal y cita quincenal de café con un excompañero. A la semana 10, la BADS Global ascendió a **112 puntos** (Activación = 31, Evitación = 12), reincorporándose progresivamente a su despacho profesional.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE RIESGO

ALERTA: EVITACIÓN Y RIESGO DE DESESPERANZA

Puntuaciones de Evitación/Rumiación **>= 38** asociadas a Activación **< 8** configuran un estado de colapso conductual. Descartar riesgo de negligencia severa o ideación autolítica activa mediante entrevista estructurada.

ERROR HABITUAL EN EL CÁLCULO GLOBAL

Recordar que para obtener el BADS Total Global, las tres subescalas negativas (Evitación, Laboral y Social) deben restarse de sus respectivos máximos teóricos (48, 30 y 30) antes de sumarse a Activación.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Kanter, J. W., Mulick, A. M., Busch, A. M., Berlin, K. S., & Martell, C. R. (2007). The Behavioral Activation for Depression Scale (BADS): Psychometric properties and factor structure. *BMC Psychiatry*, 7(1), 71.
2. Barraca, J., Pérez-Álvarez, M., & Lozano Bleda, R. (2011). Avoidance and activation as keys to depression: Adaptation of the Behavioral Activation for Depression Scale (BADS) in a Spanish sample. *Psicothema*, 23(1), 145–152.
3. Martell, C. R., Dimidjian, S., & Herman-Dunn, R. (2013). *Behavioral activation for depression: A clinician's guide*. Guilford Press.
4. Jacobson, N. S., et al. (1996). A component analysis of cognitive-behavioral treatment for depression. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 64(2), 295–304.